Kinesfera
Creando Sentido Al Juego

INFORME DE EVALUACIÓN KINESIÓLOGICA

Antecedentes Personales

Nombre: Mauro Valentino Mora Cofre
Fecha de nacimiento: 09-04-2026
Edad cronológica: 5 meses y 2 días
Fecha de emisión del informe: 11-09-2026
Diagnóstico: Limitación funcional de la movilidad cervical y Plagiocefalia moderada posicional derecha, asociado a retraso en la adquisición de hitos posturales y alteraciones leves en el procesamiento sensorial.
Instrumento de evaluación: Anamnesis, observación de parámetros psicomotores cualitativos, protocolo de mediciones craneales y Medida de Procesamiento Sensorial, Segunda Edición (SPM-2) - Nivel de edad Infantil.

Objetivos de la intervención inicial:

- Contribuir en el desarrollo de una óptima integración sensorio-motriz.
- Regular el tono muscular, favoreciendo la actividad postural y antigravitatoria.
- Corrección postural de la cabeza y alineación del cuerpo.
- Aumentar el rango de movimiento cervical, especialmente hacia la izquierda.
- Estimular reacciones de equilibrio, protección y enderezamiento.
- Normalizar la asimetría craneal y prevenir progresión de deformidades posicionales.
- Confort sensorial: discriminación, integración e inhibición de estímulos sensoriales sin perturbar las respuestas motoras.
- Facilitar el aprendizaje de movimientos normales con explotación completa de su entorno.
- Promover hitos motores acordes a su edad (giro, sedestación autónoma).

Anamnesis Inicial

Usuario derivado por pediatría y CESFAM por observación de plagiocefalia derecha, notada desde los 3 meses de edad. Nacimiento por parto normal a las 40 semanas, en posición cefálica. Peso al nacer: 3.200 g, talla: 49 cm. Puntaje Apgar 9. Lactancia materna durante el primer mes, luego alimentación con fórmula por dificultad para subir de peso. Acople normal. Radiografía de cadera a los 3 meses normal. Sueño nocturno de corrido (aproximadamente 12 horas), con siestas cortas de 15-20 minutos. Antecedentes familiares: sin antecedentes. Circunferencia craneal: 43 cm. Sobre Percentil 97.

Kinesfera
Creando Sentido Al Juego

Observación General Inicial.

Protocolo de Plagiocefalia (Criterio Sant Joan de Deu):

Mediciones craneales:	Criterio
D1: 145 mm	Diferencia: 13 mm - Plagiocefalia Moderada.
D2: 132 mm	

Protocolo de Braquicefalia: (Criterio Sant Joan de Deu):

Índice cefalométrico:	Criterio
AP: 143 mm	Índice: 88,1% - braquicefalia leve.
BP:126 mm	

Componentes Psicomotrices	Observaciones	
Movimiento	Apariencia facial: Sonríe y reacciona a estímulos con muecas y cerrando los ojos. Movimientos oculares: Intermitentes, con desviación de los ojos y rango de movimiento limitado hacia la izquierda. Respuesta visual: Sigue el objeto en rango incompleto, con diferencia hacia la izquierda. Respuesta auditiva: Reacción con dificultad al estímulo, con asimetría de respuesta con diferencia hacia la izquierda. Succión/deglución: Buen acople y deglución normal. Movimiento Normal. Cantidad: letos en decúbito supino. No gira hacia decúbito prono de forma autónoma. Logra y mantiene sedestación con apoyo de un adulto. Calidad: Libre, alternándose y uniforme en decúbito supino, con dificultad en el control de cabeza.	
	Hito	Observación
	Control de cabeza	Mantiene la cabeza erguida en sedente con compensaciones.
	Sedestación	Deja caer la cabeza hacia delante con columna curvada.
	Agarre voluntario	Dedos y pulgar con agarre inmaduro.
	Patada en supino	Toca los dedos de los pies.
	Giro	Giro hacia la derecha más que hacia la izquierda.
	Prono	Permanece en prono sin gateo, con codos por detrás de la línea de los hombros.
	Bipedestación	Se mantiene con soporte.
	Marcha	Rebota, no presenta el reflejo acorde a la edad.

<table>
<tr><td>Postura y tono muscular.</td><td colspan="2">Tono conservado en extremidades. Reacciones posturales y reflejos, con los siguientes hallazgos:

- Reacciones de equilibrio: Se observan dificultades.

- Reacción a la tracción (al sedente): Presenta bajo control de cabeza. Fuerza proximal en extremidades superiores de M3 (vence gravedad).

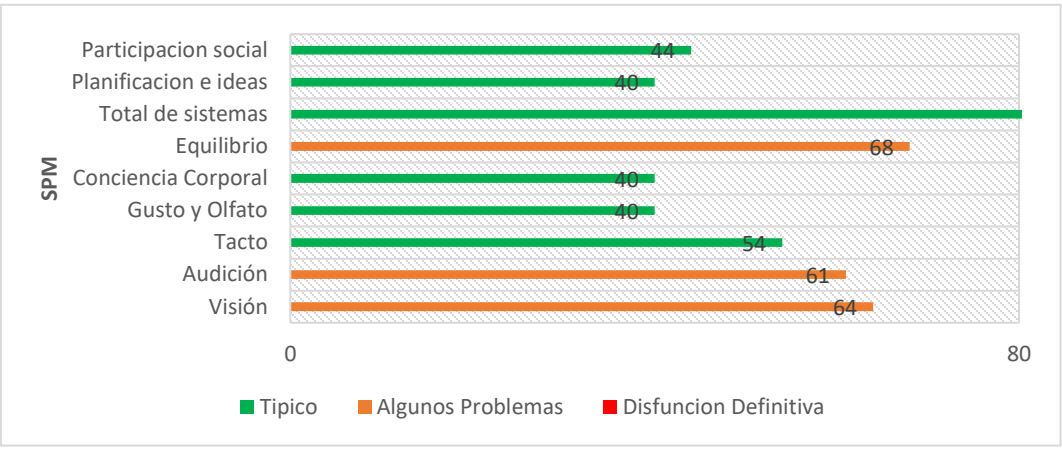
- Reacción de Landau: con dificultad

- Reacción de enderezamiento (en posición de pie): patea simétricamente.

- Sensibilización planta del pie: Sin problemas.

- Prueba de Ortolani-Barlow: Negativa.
- Reflejos ostetendinosos: Fáciles de evocar en bíceps y rodillas.</td></tr>
<tr><td></td><td>Prueba</td><td>Resultado</td></tr>
<tr><td></td><td>Signo del chal</td><td>Rango completo, el codo pasa y llega a la línea media.</td></tr>
<tr><td></td><td>Hombro pasivo</td><td>Resistencia normal, con ligera flexión de hombro y codo.</td></tr>
<tr><td></td><td>Pronación/supinación</td><td>Sin resistencia.</td></tr>
<tr><td></td><td>Aductores de cadera</td><td>Abducción de 150°-160° (normal).</td></tr>
<tr><td></td><td>Ángulo poplíteo</td><td>Normal entre 90°-170°.</td></tr>
<tr><td></td><td>Dorsiflexión de tobillo</td><td>Normal entre 30° a 85°.</td></tr>
<tr><td>Relación con los objetos</td><td colspan="2">Se observa seguimiento visual de objetos y personas. Responde a estímulos auditivos, girando la cabeza hacia la fuente del sonido con dificultad del giro hacia la izquierda.</td></tr>
<tr><td>Relación con el espacio.</td><td colspan="2">Se observa movilidad general activa en decúbito supino. En decúbito prono presenta tolerancia, lo que facilita la exploración del espacio desde esa posición.</td></tr>
<tr><td>Relación con el tiempo</td><td colspan="2">Movimientos simétricos y asimétricos. Genera vínculo con el kinesiólogo mediante toma en brazos y comunicación.</td></tr>
<tr><td>Relación con el otro</td><td colspan="2">Establece vínculo con el kinesiólogo participando en todas actividades. En compañía siempre de la madre.</td></tr>
<tr><td>Lenguaje</td><td colspan="2">Estado consciente, mantiene el interés durante la evaluación. Estado emocional feliz y sonriente. Orientación social adecuada, acepta el acercamiento.</td></tr>
</table>

Kinesfera
Creando Sentido Al Juego



Interpretación cualitativa de los hallazgos sensoriales:

Los resultados del SPM-2 revelan un perfil sensorial con algunas dificultades en las áreas:

- **Visión:** Sugiere dificultades leves en el procesamiento visual, que podrían manifestarse como limitación en el seguimiento visual completo y desviación intermitente de los ojos.
- **Audición:** Posible hipersensibilidad auditiva leve o dificultades en el procesamiento de sonidos, con respuesta dudosa y asimétrica.
- **Equilibrio y Movimiento**: Alteraciones vestibulares leves que impactan el equilibrio y la seguridad postural, relacionadas con el retraso en el control cefálico y la sedestación.
- Las áreas de tacto, gusto/olfato, conciencia corporal, planificación e ideas y participación social se encuentran dentro de parámetros normales, lo que indica que Mauro cuenta con buenas bases para el desarrollo de estas funciones.

Conclusiones Iniciales:

Mauro presenta un cuadro de limitación funcional de movilidad de cuello hacia la izquierda asociado a una Plagiocefalia moderada posicional derecha (diferencia de 13 mm) y Braquicefalia Leve (índice cefalométrico de 88.1%). La asimetría craneal es significativa y requiere intervención temprana.

Se destaca como hallazgo relevante:

- **Retraso en hitos motores posturales:** Dificultad para mantener el control cefálico en sedente, sedestación inestable, giro solo hacia un lado, y ausencia de reacciones de protección y paracaídas.
- **Limitación de la movilidad cervical:** Evidenciada por la asimetría en la respuesta visual y auditiva, con diferencia hacia la izquierda, y la desviación intermitente de los ojos.
- **Asimetría postural**: Ligera rotación interna de piernas y pies, que podría estar relacionada con la preferencia postural y la plagiocefalia.
- **Retraso en la adquisición de reacciones posturales automáticas:** Ausencia de reacción de protección de brazos y paracaídas, lo que sugiere inmadurez en la integración de reflejos posturales.

- **Perfil sensorial con algunas dificultades:** En visión, audición y equilibrio/movimiento, según los resultados del SPM-2.

Se requiere una intervención kinésica temprana e intensiva para:

1. Aumentar el rango de movimiento cervical, especialmente hacia la izquierda.
2. Corregir la asimetría craneal (plagiocefalia moderada) y prevenir la progresión de la braquicefalia.
3. Estimular las reacciones de protección y paracaídas.
4. Fortalecer la musculatura axial para lograr un control cefálico y sedestación estables.
5. Favorecer el giro hacia ambos lados.
6. Abordar las dificultades sensoriales (visión, audición y equilibrio) mediante estrategias de integración sensorial.
7. Promover hitos motores acordes a su edad (giro, sedestación autónoma, gateo).

Plan de Intervención y Recomendaciones Iniciales.

- **Área Motora:**
- **Movilidad Cervical**: Movilizaciones pasivas suaves y estiramientos de la musculatura cervical (especialmente ECOM izquierdo). Estimulación activa de la rotación hacia el lado más limitado (izquierdo) mediante seguimiento visual y sonoro.
- **Control Cefálico:** Fortalecimiento de extensores cervicales en prono (boca abajo) y en suspensión ventral. Trabajo de seguimiento visual para promover la rotación activa y simétrica.
- **Sedestación**: Facilitación de la sedestación con apoyo, trabajando la musculatura axial (abdominales y extensores de espalda). Progresión hacia sedestación con apoyo con estímulos motivantes.
- **Reacciones de Protección:** Estimulación de la reacción de paracaídas hacia delante y de protección de brazos mediante balanceos suaves y caídas controladas.
- **Giros**: Facilitación del giro desde supino a prono y viceversa, priorizando el lado izquierdo (menos desarrollado).
- **Fortalecimiento Muscular:** Fortalecimiento de musculatura abductora de cadera y rotadores externos para contrarrestar la rotación interna de piernas.

Área de Integración Sensorial (basado en resultados SPM-2):

- **Visión:** Actividades de seguimiento visual con objetos de alto contraste, movimientos lentos y progresivos para mejorar el rango de seguimiento y la simetría ocular.
- **Audición:** Estrategias de desensibilización auditiva progresiva, utilizando sonidos de baja intensidad y aumentando gradualmente. Uso de música suave y sonidos rítmicos para la regulación.
- **Equilibrio y Movimiento:** Balanceos en diferentes planos, movimientos rítmicos para estimular la integración vestibular y mejorar el equilibrio.

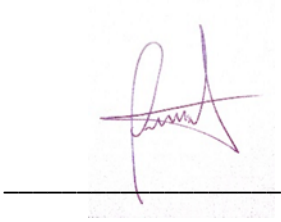
Kinesfera
Creando Sentido Al Juego

Educación Familiar:

- **Posicionamiento:** Instruir en cambios posturales frecuentes durante la vigilia. Favorecer el decúbito prono supervisado (boca abajo) en períodos cortos pero frecuentes. Durante el sueño, colocar a Mauro boca arriba con la cabeza girada hacia la izquierda (para contrarrestar la preferencia hacia la derecha), alternando la posición cada noche.
- **Estimulación en el Hogar:** Colocar estímulos visuales y sonoros prioritariamente hacia el lado izquierdo durante el juego, la alimentación y el cambio de pañal, para incentivar la rotación activa hacia ese lado.
- **Manejo en Brazos**: Cargar a Mauro en posición vertical y en prono sobre el antebrazo, con la cabeza hacia afuera, para favorecer la extensión cervical. Alternar los brazos y evitar posturas que mantengan la rotación.
- **Juego y Estimulación:** Realizar juegos de seguimiento visual con objetos sonoros, espejos y caras, incentivando el movimiento de cabeza y la atención.
- **Observación de Hitos:** Solicitar a la familia que registren los avances en el control cefálico, la tolerancia al prono y los giros, para ajustar el plan de tratamiento según la evolución.

Seguimiento:

- Se sugiere control kinésico 2 veces por semana para abordar la limitación funcional de giro de cuello, la plagiocefalia y el dificultad en el desarrollo de los hitos motores.
- Reevaluación a las 5 sesiones con mediciones craneales (protocolo de plagiocefalia y braquicefalia) y reevaluación de rangos cervicales y hitos motores.
- Coordinación con pediatría para seguimiento integral.



Aldo Olivares Araya

Kinesiólogo, Especialista en Psicomotricidad.